Клинические рекомендации

Саркоидоз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D86.0** — Саркоидоз легких **D86.1** — Саркоидоз лимфатических узлов **D86.2** — Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов **D86.3** — Саркоидоз кожи **D86.8** — Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций **D86.9** — Саркоидоз неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Российское респираторное общество; Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/736_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта 5

2.6 Внелёгочные локализации 6

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Физикальное обследование 6

3.3 Общий (клинический) анализ крови 7

3.4 Оценка функции почек 7

3.5 Активность ангиотензинпревращающего фермента 7

3.6 С-реактивный белок 7

3.7 Кальций крови и суточной мочи 7

3.8 Иммуноглобулины A, M, G 7

3.9 Исключение туберкулёза 7
3.10 Рентгенография органов грудной полости 8
3.11 Компьютерная томография органов грудной полости 8
3.12 Другие методы визуализации 8
3.13 Исследование функции внешнего дыхания 8
3.14 Электрокардиография 8
3.15 Биопсия 9
3.16 Дифференциальная диагностика 9
4. Лечение 9
4.1 Активное наблюдение 9
4.2 Системные глюкокортикоиды 10
4.3 Ингаляционные глюкокортикоиды 10
4.4 Препараты второй и третьей линии 10
4.5 Другие методы лечения 11
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Показания к госпитализации 12
5.2 Диспансерное наблюдение 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной этиологии, при котором образуются неказеифицирующиеся гранулёмы, поражаются многие органы и активируются Т-клетки в очагах воспаления.
- Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев. Формы поражения:
  1. синоназальная: заложенность носа, корки, носовые кровотечения, узелки на перегородке и верхней раковине;
  2. увеличение нёбных миндалин;
  3. поражение гортани с риском обструкции;
  4. сенсоневральная или кондуктивная тугоухость.

  Диагноз требует биопсии.
- Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма: увеличение околоушных слюнных желёз, передний увеит, лихорадка, иногда паралич лицевого нерва.
- Диагноз верифицируется морфологически: гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине; синдромы Лёфгрена, Хеерфордта, ознобленная волчанка позволяют установить предположительный диагноз без биопсии.
- Бессимптомным пациентам без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**; системные глюкокортикоиды показаны при прогрессировании, угрозе функции органа или жизни.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной этиологии, характеризующимся образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов.

Синдром Лёфгрена является вариантом острого течения саркоидоза, проявляющимся внутригрудной лимфаденопатией, узловатой эритемой, суставным синдромом и лихорадкой.

Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма является вариантом острого течения саркоидоза, проявляющимся увеитом, паротитом, лихорадкой и в ряде случаев сопровождающимся параличом лицевого нерва (паралич Белла).

Саркоидная реакция представляет собой образование локализованных групп эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулём саркоидного типа в ответ на экзогенные факторы (импланты, татуировки, филлеры), при применении интерферонов, перифокально при злокачественных опухолях и паразитарных заболеваниях; в отличие от саркоидоза поражение только локальное.

2.2 Этиология и эпидемиология

Решающую роль играет воздействие окружающей среды на генетически предрасположенный организм. Вероятными триггерами являются изменённые микобактерии, пропионовокислые бактерии, боррелии; саркоидная реакция возможна при применении интерферонов, индукторов интерфероногенеза и таргетной биологической терапии.

Саркоидоз встречается во всех возрастах и у обоих полов; в России преобладают женщины молодого и зрелого возраста. Синдром Лёфгрена наблюдается в 3,7–22% случаев, семейный саркоидоз в среднем в 9,5%.

2.3 Классификация

Классификация внутригрудного саркоидоза по данным лучевого обследования

Стадия	Рентгенологическая картина	Частота
0	нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки	5%
I	увеличение внутригрудных лимфатических узлов, паренхима лёгких не изменена	45%
II	увеличение внутригрудных лимфатических узлов и изменения паренхимы лёгких	30%
III	изменения паренхимы без увеличения внутригрудных лимфатических узлов	15%
IV	выраженный фиброз лёгких как ведущий синдром	5%

Рентгенологическая стадия не отражает стадийность клинического течения; КТ точнее характеризует распространённость изменений. В диагнозе перечисляют все поражённые органы и системы.

1. **по локализации**: классический (внутригрудной), с преобладанием внелёгочных поражений, генерализованный;
2. **по течению**: с острым началом (синдромы Лёфгрена, Хеерфордта — Вальденстрёма), изначально хронический, с фиброзированием, рецидив;
3. **особые формы**: саркоидоз детей моложе 5 лет; саркоидоз, рефрактерный к системным глюкокортикоидам.

Обострением называют реактивацию **в течение года** после окончания основного курса лечения, рецидивом считают возобновление проявлений **через 1 год и более** после лечения или спонтанной регрессии.

Признаки прогрессирования

1. ухудшение клиники, нарастание изменений в лёгких на КТ;
2. появление или усиление внелёгочных проявлений;
3. снижение ФЖЕЛ на **10% и более** или DLco на **15%** за 1 год;
4. формирование лёгочной гипертензии;
5. повышение АПФ, гиперкальциурия и (или) гиперкальциемия.

Построение диагноза

1. локализация (поражённые органы), при внутригрудном саркоидозе рентгенологическая стадия 0–IV;
2. активность: 0 (неактивный), 1 (активный) (или «синдром Лёфгрена», «синдром Хеерфордта — Вальденстрёма»);
3. течение: стабильное, прогрессирующее, регрессирующее, волнообразное, обострение, рецидив;
4. осложнения: недостаточность органа, стойкие структурные изменения;
5. подтверждение диагноза на клеточном или тканевом уровне.

2.4 Клиническая картина

Чаще течение малосимптомное, хроническое. Наиболее выражены жалобы при синдроме Лёфгрена и при «увеопаротидной лихорадке» (синдроме Хеерфордта — Вальденстрёма).

Синдром Лёфгрена (как правило, не дольше 2 месяцев)

1. лихорадка;
2. узловатая эритема;
3. двусторонний периартрит, преимущественно голеностопных суставов;
4. двусторонняя лимфаденопатия корней лёгких.

Общие симптомы

1. слабость и утомляемость (30–80%), оцениваются по шкале FAS;
2. лихорадка (20–60%) или длительный субфебрилитет;
3. боль, тревога, депрессия, когнитивная дисфункция, нейропатия мелких волокон.

При поражении лёгких и внутригрудных лимфатических узлов возникают боль и дискомфорт в грудной клетке, одышка (оценивается по шкале mMRC), сухой кашель из-за давления увеличенных лимфатических узлов на бронхи или раздражения гранулёмами нервных окончаний.

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта

Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев саркоидоза; чаще это случайные находки.

1. **синоназальный**: заложенность носа, ринорея, корки, носовые кровотечения, боль в носу, нарушения обоняния; эндоскопически выявляется хронический риносинусит с узлами и мелкими узелками на перегородке и верхней раковине; необходима гистологическая верификация;
2. **нёбные миндалины**: бессимптомное одно- или двустороннее увеличение, неказеифицирующиеся гранулёмы выявляются после тонзиллэктомии;
3. **гортань**: дисфония, дисфагия, кашель; отёк и эритема слизистой оболочки, узелки и узлы; возможна угрожающая жизни обструкция; диагноз устанавливается по данным биопсии;
4. **ухо**: снижение слуха, шум в ушах, глухота, вестибулярные расстройства; сенсоневральная тугоухость разной степени, реже поражение среднего уха с кондуктивной тугоухостью;
5. **полость рта и ротоглотка**: опухание и изъязвление слизистой оболочки, языка, губ, дёсен; орофарингеальный саркоидоз может быть причиной обструктивного апноэ сна.

Саркоидоз слюнных желёз (6%) проявляется двусторонним опуханием околоушных желёз, в том числе в составе синдрома Хеерфордта — Вальденстрёма.

Дифференциальная диагностика

1. хронический сиалоаденит;
2. туберкулёз;
3. болезнь кошачьей царапины;
4. актиномикоз;
5. синдром Шегрена.

Поражение черепных нервов является самым частым проявление нейросаркоидоза (50% случаев), чаще всего лицевого, затем зрительного нерва. Паралич лицевого нерва обычно проходит за несколько месяцев даже без лечения. Описаны потеря слуха (VIII нерв), лицевая боль и нарушения чувствительности (V нерв).

Ознобленная волчанка (lupus pernio) представляет собой хроническое рецидивирующее поражение кожи носа, щёк, ушных раковин и пальцев. Поражённые участки уплотнены; их цвет красный, пурпурный или фиолетовый. Часто сочетается с поражением лёгких, костей и глаз и резистентна к лечению.

Периферические лимфатические узлы поражаются в 10–25%, чаще задние и передние шейные и надключичные: плотноэластические, не размягчаются и не образуют свищей. Обнаружение эпителиоидно-клеточных гранулём в удалённом узле требует дифференциальной диагностики с саркоидной реакцией и другими гранулематозами.

2.6 Внелёгочные локализации

Кожа (10–30%): узлы, бляшки, «ожившие рубцы», гранулёмы в татуировках; узловатая эритема саркоидных гранулём не содержит. Глаза (5–25%): передний (70–75%) и задний увеит, которые требуют офтальмологического обследования. У детей до 5 лет характерна триада: увеит, поражение кожи, артрит без поражения лёгких.

Сердце (2–18%) является жизнеугрожающей локализацией: нарушения ритма и проводимости, внезапная смерть. Поражение нервной системы (5–10%) проявляется краниальными нейропатиями, асептическим менингитом, гипоталамо-гипофизарной дисфункцией. Возможно также поражение почек, печени, селезёнки, костей (кистоидный остеит фаланг), суставов.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, лучевым, функциональным, лабораторным и морфологическим данным и требует исключения саркоидной реакции и сходных заболеваний. Диагноз верифицируется выявлением гранулём без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине.

Синдром Лёфгрена, синдром Хеерфордта, ознобленная волчанка и бессимптомная двусторонняя внутригрудная лимфаденопатия настолько специфичны, что позволяют установить предположительный диагноз без морфологического исследования.

Диагноз устанавливает и формулирует пульмонолог медицинской организации 2–3 уровня после обследования.

3.2 Физикальное обследование

Показания

1. все пациенты: обследование всех органов и систем.

Диагностические признаки

1. изменения кожи, особенно в области старых рубцов и татуировок;
2. безболезненные подвижные увеличенные периферические лимфатические узлы, подкожные саркоиды Дарье — Русси;
3. увеит, эписклерит при осмотре конъюнктивы и радужки;
4. увеличение печени и селезёнки.

3.3 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. повышение СОЭ при остром течении;
2. лимфопения и моноцитоз как признаки активности;
3. тромбоцитопения при поражении печени, селезёнки, костного мозга.

3.4 Оценка функции почек

Показания

1. все пациенты: при первичной диагностике и **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

Исследования

1. общий анализ мочи;
2. креатинин и мочевина крови;
3. скорость клубочковой фильтрации (СКФ).

3.5 Активность ангиотензинпревращающего фермента

Показания

1. подростки и взрослые: при выявлении и в динамике как маркер активности, но не как дифференциально-диагностический критерий.

Диагностические признаки

1. норма **в 6–18 лет**: **29–112 ед.**;
2. норма **старше 18 лет**: **20–70 ед.**;
3. значимо повышение **более 150%** от верхней границы нормы.

3.6 С-реактивный белок

При остром саркоидозе определяют С-реактивный белок: его умеренное повышение характерно для синдрома Лёфгрена.

3.7 Кальций крови и суточной мочи

Кальций крови и суточной мочи исследуют при выявлении и в динамике: гиперкальциемия (5%) и гиперкальциурия (25%) являются признаками активного процесса.

3.8 Иммуноглобулины A, M, G

Иммуноглобулины A, M, G определяют при первичном обследовании для дифференциальной диагностики с иммунодефицитами, сопровождающимися гранулёмами (ОВИН).

3.9 Исключение туберкулёза

1. детям **до 7 лет**: проба Манту с 2 ТЕ (при активном саркоидозе отрицательна в 80–85%);
2. всем пациентам при первичной диагностике: проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (АТР), обязательна;
3. при отказе от кожных проб или их невозможности: IGRA-тесты;
4. при положительном результате: углублённое обследование у фтизиатра.

Проба с АТР не проводится, если пациент получает иммуносупрессивную терапию.

3.10 Рентгенография органов грудной полости

Показания

1. все пациенты: первичная диагностика и определение стадии;
2. динамическое наблюдение: только при невозможности КТ.

Диагностические признаки

1. симметричное увеличение лимфатических узлов корней лёгких и средостения;
2. двусторонние очагово-интерстициальные изменения при относительно удовлетворительном состоянии.

3.11 Компьютерная томография органов грудной полости

Показания

1. все пациенты: первичная диагностика и динамическое наблюдение.

Диагностические признаки

1. увеличенные лимфатические узлы центрального средостения и корней лёгких без перифокальной инфильтрации;
2. перилимфатические мелкие очаги вдоль бронхососудистых пучков, междолевых щелей и плевры.

3.12 Другие методы визуализации

Показания

1. МРТ сердца и (или) головного мозга: подозрение на саркоидоз сердца и центральной нервной системы;
2. ПЭТ-КТ всего тела: уточнение локализации и выбор места биопсии (накопление ФДГ не отличает саркоидоз от опухоли или инфекции).

Исследования при подозрении на генерализованный или внелёгочный саркоидоз

1. УЗИ брюшной полости;
2. МРТ головного мозга и сердца;
3. эхокардиография;
4. рентгенография и МРТ поражённых костей и мягких тканей.

3.13 Исследование функции внешнего дыхания

Показания

1. все пациенты при первичной диагностике вне зависимости от локализации;
2. активная фаза: **не реже 1 раза в 3 месяца**;
3. динамическое наблюдение: ежегодно.

Методы

1. спирометрия (ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ);
2. диффузионная способность лёгких (DLco) в пульмонологических центрах;
3. пульсоксиметрия на всех этапах, при необходимости тест с 6-минутной ходьбой.

3.14 Электрокардиография

ЭКГ является обязательным компонентом первичного обследования; при нарушениях ритма показано холтеровское мониторирование.

3.15 Биопсия

Показания

1. все пациенты на этапе первичной диагностики: бронхоскопия с биопсией.

Методы биопсии (выбирают по ситуации)

1. прямая;
2. чрезбронхиальная;
3. тонкоигольная биопсия лимфатических узлов;
4. криобиопсия.

Всем пациентам обязательно исключение туберкулёза в биоптатах и промывных водах бронхов: микроскопия, посев, ПЦР.

При неинформативности эндоскопической биопсии выполняются миниинвазивные хирургические вмешательства: видеоторакоскопическая резекция лёгкого, биопсия внутригрудных лимфатических узлов.

При внелёгочном саркоидозе выполняется биопсия поражённого органа: периферического лимфатического узла, кожи, подкожных образований, печени. Метод выбирают лечащий врач и хирург.

3.16 Дифференциальная диагностика

1. **внутригрудная лимфаденопатия**: туберкулёз, нетуберкулёзный микобактериоз, бруцеллёз, токсоплазмоз, болезнь Кикучи, болезнь кошачьей царапины, саркоидная реакция при карциноме, лимфомы, острый лимфобластный лейкоз, GLUS-синдром, IgG4-ассоциированное заболевание, ОВИН;
2. **диссеминация в лёгких**: туберкулёз, микозы, опухолевая диссеминация, гиперчувствительный пневмонит, пневмокониозы, лекарственные реакции, гистиоцитоз X, гранулематоз с полиангиитом (Вегенера), интерстициальные пневмонии, ОВИН;
3. **дети до 5 лет**: увеиты, паротиты, артриты и поражения кожи другой этиологии.

---

4. Лечение

Этиотропной терапии нет. Активная терапия показана при угрозе недостаточности органов, угрозе жизни или потере качества жизни; в остальных случаях проводится активное наблюдение. Необходимость лечения соотносят с тяжестью последствий глюкокортикоидной, цитостатической или биологической терапии.

4.1 Активное наблюдение

Бессимптомным пациентам (детям и взрослым) без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**, поскольку частота спонтанных ремиссий высока.

Взрослым с бессимптомным течением без функциональных нарушений в качестве альтернативы возможно назначение #альфа-токоферола ацетата или его сочетания с #пентоксифиллином на срок не менее **6 месяцев**. Дозы в тексте рекомендации противоречивы (мкг и мг); варианты приведены в «Подробнее».

1. #альфа-токоферола ацетат: в разделе 3.1 указано «200 мкг 2 раза в сутки» и, ниже, «200–400 мг в сутки»;
2. #пентоксифиллин: в разделе 3.1 указано «400–2000 мкг в сутки» и, ниже, 600–1200 мг в сутки (при стероидзамещающей терапии до 2000 мг).

4.2 Системные глюкокортикоиды

СГКС являются препаратами первой линии при прогрессирующем течении, выраженных симптомах, внелёгочных проявлениях с нарушением функции органа, lupus pernio, угрозе жизни или резком снижении качества жизни.

1. преднизолон, взрослым: внутрь утром 20–40 мг в сутки (0,5 мг/кг) **4 недели**, затем снижение по 5 мг в месяц до минимальной поддерживающей дозы; общая длительность приёма **12–24 месяца**.

Эффект оценивают **через 3 месяца**, при его отсутствии переходят на альтернативную терапию. Препараты СГКС следует применять **не менее 10–12 месяцев**. После отмены обострения развиваются у 30–80%. О полной ремиссии судят **через 3 года** после прекращения терапии.

При отсутствии эффекта **через 3–6 месяцев** и при прогрессировании следует пересмотреть диагноз и исключить инфекционную, прежде всего туберкулёзную, природу изменений. При рецидиве после полноценного курса СГКС показаны препараты второй линии, предпочтительно метотрексат.

Нежелательные явления: повышение артериального давления и уровня глюкозы крови, увеличение массы тела, остеопороз (лечение бисфосфонатами), надпочечниковая недостаточность.

4.3 Ингаляционные глюкокортикоиды

Показания

1. саркоидоз гортани;
2. выраженный кашель.

В качестве основной терапии саркоидоза ингаляционные глюкокортикоиды не рекомендуются. Комбинации с бронхолитиками применяют только при доказанной обратимой бронхообструкции.

4.4 Препараты второй и третьей линии

#Метотрексат применяют как препарат второй линии (при рефрактерности к СГКС, побочных реакциях или для снижения их дозы) и как препарат первой линии в монотерапии или в комбинации с СГКС. Обладает тератогенностью, противопоказан при беременности.

1. #метотрексат: внутрь 10–15 мг 1 раз в неделю; взрослым при нейро- и кардиосаркоидозе до 25 мг в неделю;
2. #фолиевая кислота: 5 мг 1 раз в неделю или 1 мг ежедневно, не ранее чем через 24 часа после метотрексата; терапия от 6 месяцев.

До лечения определяют АЛТ, АСТ, креатинин, общий анализ крови; в ходе лечения исследования повторяют **каждые 1–3 месяца**.

Другие препараты второй линии

Препарат	Режим дозирования	Возрастные ограничения	Нежелательные явления и противопоказания
#Азатиоприн	100–200 мг в сутки, не менее 6 месяцев	с 3 лет	гепатотоксичность, лейкопения, инфекции, повышение риска лимфомы и лейкемии
#Лефлуномид	10–20 мг в сутки; эффект не ранее чем через 3 месяца	с 18 лет	тератогенен, противопоказан при беременности; общий и биохимический анализ крови до лечения и каждые 1–3 месяца
#Микофенолата мофетил	500 мг 2 раза в день с увеличением до 750–1000 мг 2 раза в день	с 12 лет (площадь поверхности тела 1,25 м^2)	у каждого пятого пациента тошнота, диарея, лейкопения, повышение риска инфекций; регулярный общий анализ крови

Препарат	Режим дозирования	Возрастные ограничения	Нежелательные явления и противопоказания
#Циклофосфамид	500–1000 мг внутривенно каждые 3–4 недели при полиорганном поражении и рефрактерности	дети и взрослые	чаще других иммунодепрессантов вызывает инфекционные осложнения
#Гидроксихлорохин	400 мг с возможным снижением до 200 мг в сутки, 6–12 месяцев	с 6 лет	не рекомендуется при саркоидозе глаз (ретинопатия); удлиняет интервал QT, необходим регулярный ЭКГ-контроль; противопоказан при беременности

Ингибиторы ФНО-альфа применяют в третьей линии только при рефрактерном саркоидозе в профильных центрах.

1. #инфликсимаб: 3 или 5 мг/кг внутривенно на 0-й, 2-й и 6-й неделе, затем каждые 4–8 недель;
2. #адалимумаб: 40 мг в неделю.

НПВП применяют симптоматически при острых формах и артритах с выраженным болевым синдромом, по инструкции.

Антифибротическая терапия показана только взрослым при прогрессирующем фиброзе, несмотря на лечение глюкокортикоидами и препаратами второй линии.

4.5 Другие методы лечения

При хроническом рефрактерном саркоидозе применяют плазмаферез (3–4 процедуры с недельным перерывом) или экстракорпоральную модификацию лимфоцитов.

Трансплантация лёгких показана при терминальной стадии (IV, фиброз), сердца при кардиосаркоидозе с рефрактерными нарушениями ритма, печени при её тяжёлом поражении.

При дыхательной недостаточности применяют низкопоточную оксигенотерапию, в тяжёлых случаях неинвазивную ИВЛ до SpO_2 более 90%; лёгочную гипертензию лечат по рекомендациям по лёгочной артериальной гипертензии.

Немедикаментозные программы для всех пациентов

1. повышение физической активности;
2. физическая и психологическая реабилитация;
3. группы поддержки;
4. лечение боли и нарушений сна.

Разгрузочно-диетическая терапия рекомендована пациентам на ранних стадиях саркоидоза при наличии ожирения.

Компоненты медицинской реабилитации

1. лечебный режим;
2. диетотерапия;
3. физическая реабилитация (активная и пассивная);
4. респираторная физиотерапия;
5. психодиагностика и психокоррекция.

Утверждённой программы медицинской реабилитации при саркоидозе не разработано.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

1. **плановая госпитализация**: первичная комплексная, в том числе инвазивная, диагностика и подбор начальной терапии;
2. **экстренная госпитализация**: острый прогрессирующий саркоидоз с осложнениями (дыхательная недостаточность, нарушения ритма).

В большинстве случаев лечение проводится амбулаторно.

Критерии выписки

1. завершение диагностики и установление клинического диагноза;
2. назначение лечения;
3. компенсация острого состояния и осложнений, ставших причиной госпитализации.

5.2 Диспансерное наблюдение

Наблюдение пожизненное: при торакальных формах его осуществляет пульмонолог, при генерализованных и внеторакальных пульмонолог и специалист по соответствующей локализации.

Частота осмотров

1. впервые выявленный саркоидоз, первый год и сохраняющаяся активность: **каждые 3 месяца**;
2. стабилизация на 2-м году: **каждые 6 месяцев**, далее ежегодно;
3. рецидивы: каждые 3 месяца **2 года**, затем ежегодно;
4. прогрессирующее течение: каждые 3 месяца 2 года, затем каждые 6 месяцев 2 года, далее ежегодно.

Пациенты с саркоидозом относятся к иммунокомпрометированным; вакцинация проводится по национальному календарю и календарю по эпидемическим показаниям с учётом периода болезни и терапии.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Саркоидоз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	736_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское респираторное общество; Российское научное медицинское общество терапевтов; Педиатрическое респираторное общество; Российское общество фтизиатров; Российское общество рентгенологов и радиологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы #альфа-токоферола ацетата и #пентоксифиллина в разделе 3.1 указаны в микрограммах («200 мкг 2 раза в сутки», «400–2000 мкг»), а ниже в том же разделе — в миллиграммах («200–400 мг в сутки», «600 мг в сутки», «до 2000 мг»); различие в тысячу раз.